



FACULDADE
CIÊNCIAS MÉDICAS
UMA INSTITUIÇÃO FELUMA

AULA · SAÚDE DO IDOSO

Quedas no Idoso

Magnitude, desfechos, estratificação de risco e prevenção baseada em evidência

Dr. Igor Cruz Moraes

Clínica Médica · Geriatria · Medicina Intensiva

Disciplina de Saúde do Idoso — FCMMG

DISCIPLINA DE SAÚDE DO IDOSO

FCMMG

1950

Ao final, você será capaz de...

- 01** Dimensionar o impacto das quedas e seus desfechos duros no idoso.
- 0** Rastrear e estratificar o risco de queda (World Falls Guidelines 2022).
- 2** Prescrever prevenção baseada em evidência: exercício, vitamina D e revisão de
- 3** fármacos.

Por onde vamos passar

01 Magnitude e desfechos das quedas

02 O custo: fratura de quadril

03 Conceitos e síndrome pós-queda

04 Rastreio: TUG e velocidade de marcha

05 Estratificação de risco

06 Prevenção e nível de evidência

07 Fatores de risco e proteção

08 Caso, quiz e mensagens finais

01

A dimensão do problema

Quedas são comuns, graves e, em boa parte, preveníveis.



A magnitude das quedas

1 em 3

dos idosos ≥ 65 anos cai ao menos
1×/ano — e 1 em 2 após os 80.

684 mil

mortes por queda por ano no mundo
(OMS).

37,3 mi

quedas graves/ano que exigem atenção
médica (OMS).

Fonte: OMS (WHO Falls Fact Sheet); World Falls Guidelines 2022.

O que está em jogo

20–30%

de MORTALIDADE em 1 ano após fratura de quadril.

2^a

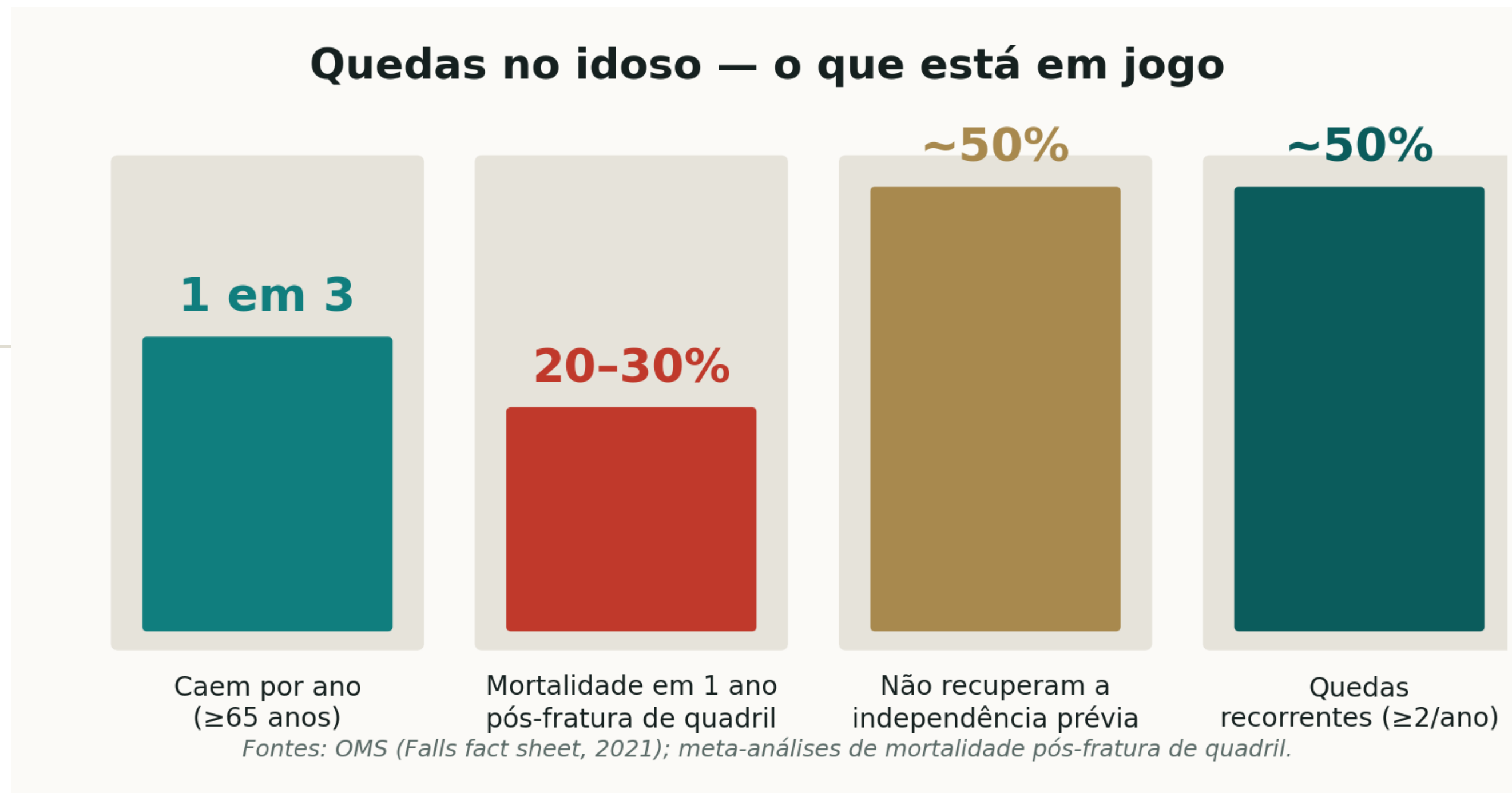
causa mundial de morte por lesão não intencional (1^a no idoso).

~50%

não recuperam a independência funcional prévia após a fratura.

Fonte: OMS; meta-análises de mortalidade pós-fratura de quadril.

Quedas em números

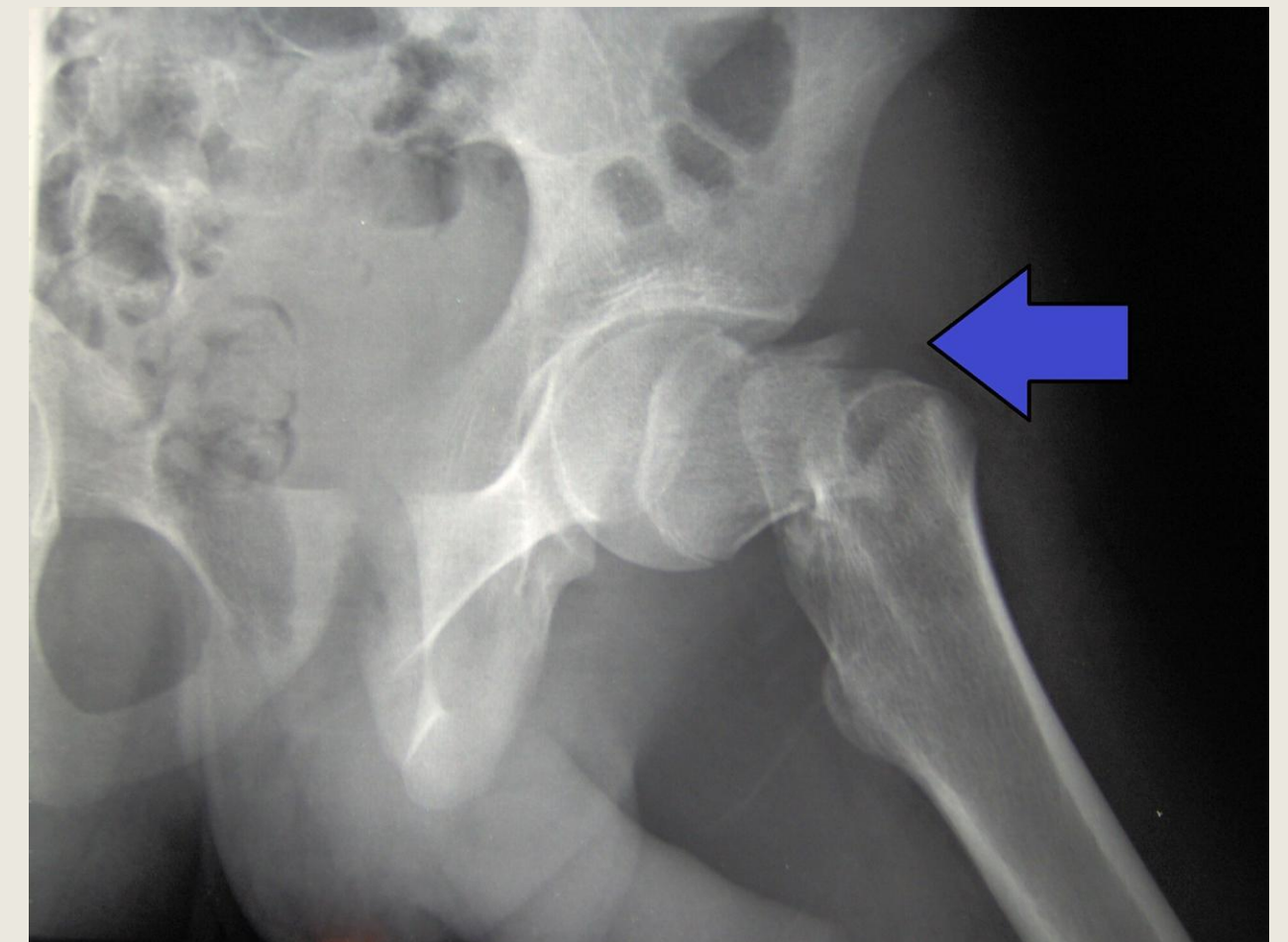


Elaboração própria (dados: OMS 2021; meta-análises pós-fratura de quadril).

O DESFECHO QUE MUDA TUDO

A fratura de quadril

- 1 Mortalidade de 20–30% no primeiro ano após a fratura.
- 2 Cerca de metade não recupera a independência funcional prévia.
- 3 Prevenir a queda é prevenir a fratura — e preservar autonomia.



Definição central

QUEDA

Enuncie aqui a definição do conceito de forma precisa, em uma ou duas frases curtas.

OMS

Síndrome pós-queda

Breve distinção em relação ao conceito central.

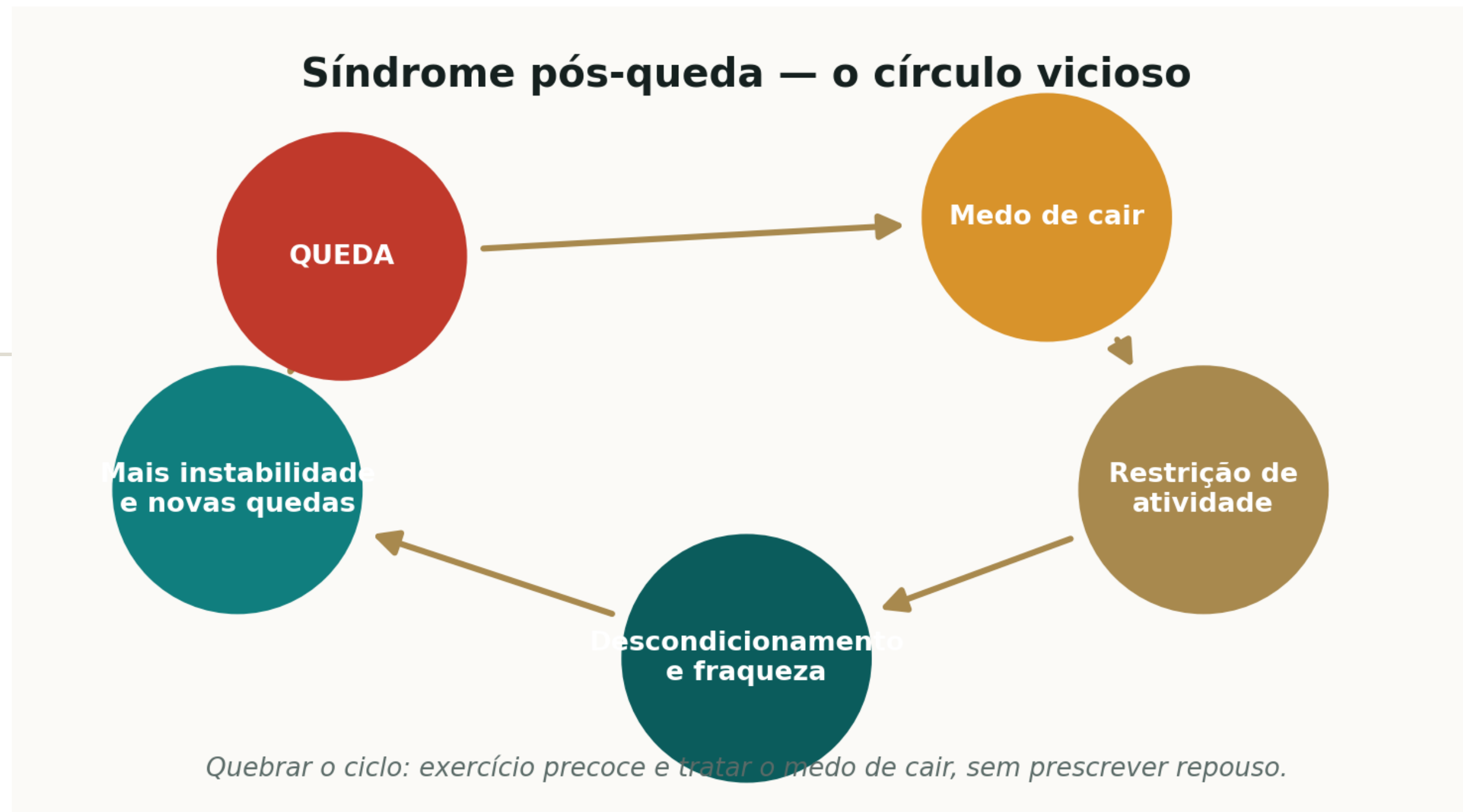
Síndrome pós-queda

Breve distinção em relação ao conceito central.

Síndrome pós-queda

Breve distinção em relação ao conceito central.

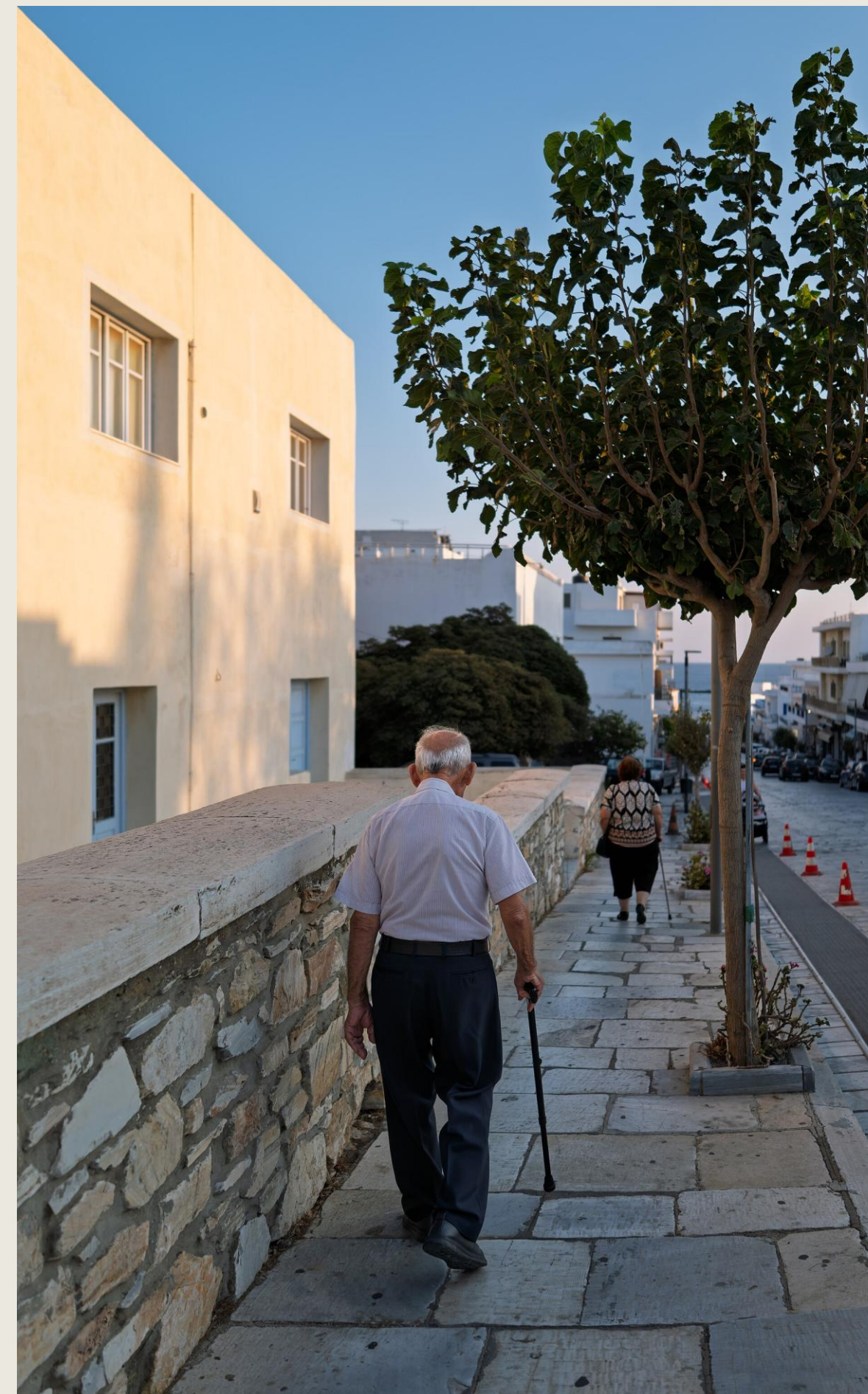
O círculo vicioso da síndrome pós-queda



Elaboração própria — Dr. Igor C. Morais, 2026.

Pergunte sobre quedas a **TODO** idoso (anual)

- 1 Caiu no último ano? Quantas vezes? Houve lesão? Tem medo de cair?
- 2 Avalie marcha e equilíbrio: Timed Up and Go (TUG) e velocidade de marcha.
Risco: $TUG > 15$ s ou velocidade de marcha $\leq 0,8$ m/s.
- 3



Por que o idoso cai?

Por que o idoso cai? Fatores intrínsecos x extrínsecos

INTRÍNSECOS (do paciente)

- Fraqueza muscular / sarcopenia
- Distúrbio de marcha e equilíbrio
- Baixa visão (catarata)
- Hipotensão ortostática
- Comprometimento cognitivo / delirium
- Doenças crônicas e dor
- Medo de cair (síndrome pós-queda)

EXTRÍNSECOS (ambiente/fármacos)

- Psicotrópicos (BZD, antipsicóticos)
- Polifarmácia (≥ 4 fármacos)
- Tapetes soltos, pisos escorregadios
- Iluminação inadequada
- Ausência de barras de apoio
- Calçado inadequado
- Escadas e desníveis

A queda costuma ser MULTIFATORIAL — intervir em vários fatores tem maior impacto.

Elaboração própria — Dr. Igor C. Morais, 2026.

World Falls Guidelines 2022 — baixo · intermediário · alto

Baixo risco

Sem queda no último ano e sem alteração de marcha/equilíbrio → orientar e reavaliar.

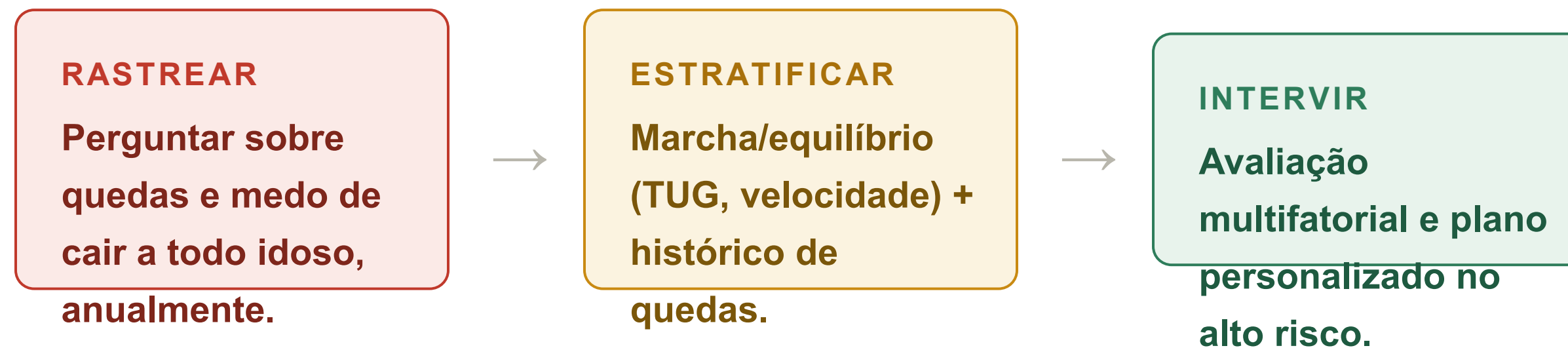
Intermediário

1 queda sem lesão OU alteração de marcha → exercício e correção de fatores.

Alto risco

≥ 2 quedas, queda com lesão, ou marcha alterada → avaliação MULTIFATORIAL.

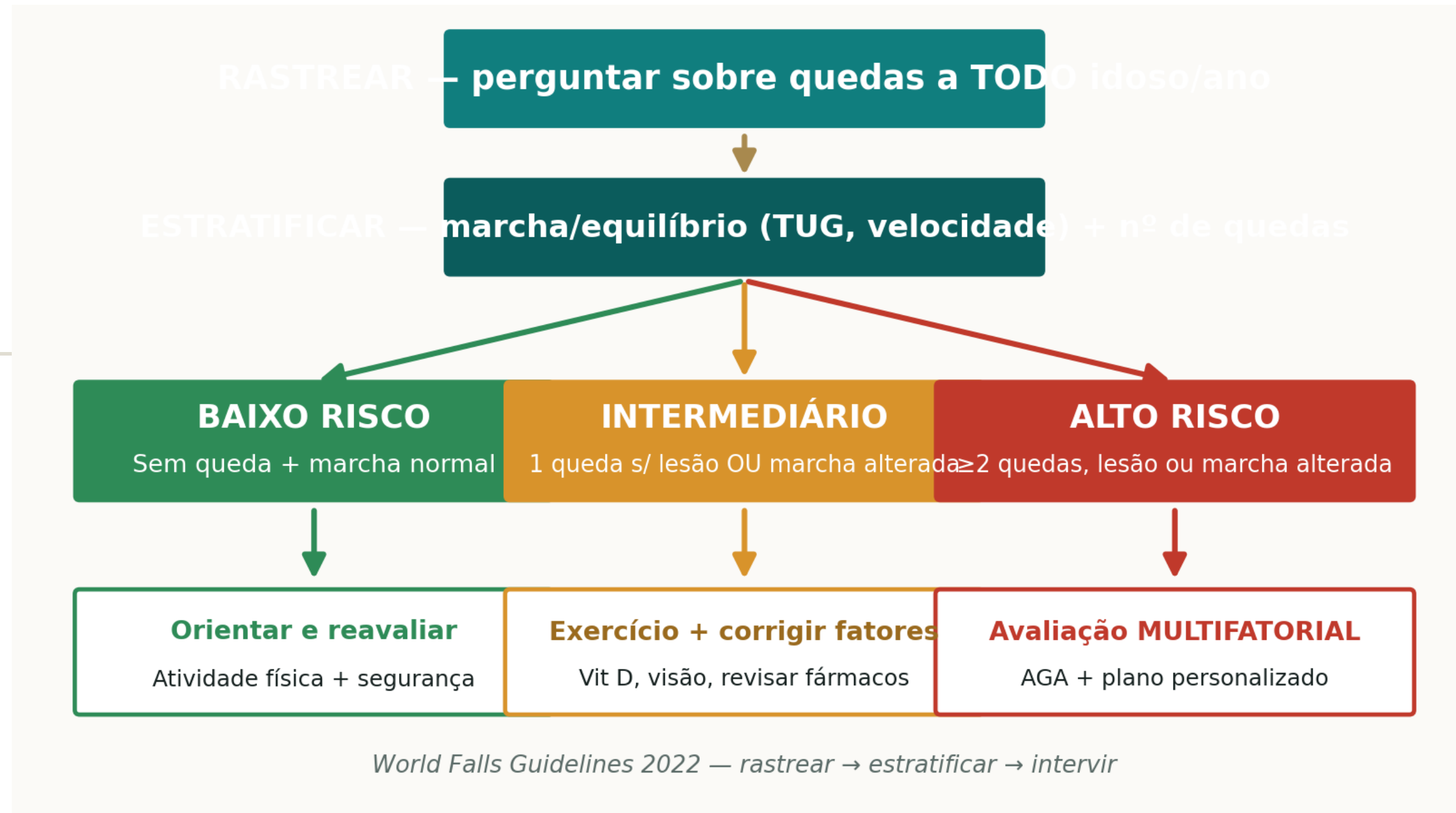
Rastrear → estratificar → intervir



■ Rastrear ■ Estratificar ■ Intervir

ALGORITMO

Estratificar e intervir — cores de alerta



Elaboração própria a partir do World Falls Guidelines 2022.

Intervenções e nível de evidência (1/2)

INTERVENÇÃO	INDICAÇÃO	TIPO	EVIDÊNCIA
Exercício (equilíbrio/força)	Otago, Tai Chi — 3×/semana	↓ 23% da taxa de quedas	AI
Vitamina D 800–1000 UI/d	Se deficiência/baixa exposição solar	↓ ~22% (uso DIÁRIO)	M
Revisão de fármacos	Desprescrever psicotrópicos (STOPPFall)	↓ exposição a queda	M

Evitar vitamina D em dose alta intermitente (pode aumentar quedas). Sempre individualizar.

Intervenções e nível de evidência (2/2)

INTERVENÇÃO	INDICAÇÃO	TIPO	EVIDÊNCIA
Segurança domiciliar	Remover tapetes, barras, iluminação	↓ quedas (maior no alto risco)	M
Correção visual	Catarata; evitar lentes multifocais ao andar	↓ risco em casos selecionados	Ba
Avaliação multifatorial	Alto risco: AGA + plano personalizado	Reduz quedas	M

Marca-passo se síncope cardioinibitória; calçado adequado; suspender contenção. Vacinação e metas de cuidado.

Efeito esperado e nível de evidência

Prevenção de quedas — efeito esperado e nível de evidência			
Intervenção	Efeito esperado	Tempo / nota	Evidência
Exercício (equilíbrio/força)	↓ 23% das quedas	≥3x/sem, contínuo	Alta
Avaliação multifatorial (AGA)	↓ quedas (alto risco)	Plano individual	Mod.
Revisão de fármacos	↓ exposição a quedas	Desprescrever (STOPPFall)	Mod.
Vitamina D 800-1000 UI/d	↓ ~22% (uso diário)	Se déficit; evitar bolus	Mod.
Segurança domiciliar	↓ quedas em casa	Tapetes, barras, luz	Mod.
Correção visual	↓ risco (selecionados)	Cuidado c/ multifocal	Baixa

RRR/efeito de meta-análises e diretrizes (Cochrane 2019; WFG 2022; USPSTF; STOPPFall).

Cochrane 2019; World Falls Guidelines 2022; USPSTF 2018; STOPPFall 2021.

Prevenção que cabe na consulta



Vitamina D3 800–1000 UI/dia se déficit (uso diário, não em bolus).



Segurança domiciliar: barras de apoio, retirar tapetes, boa iluminação.

Imagens reais (Wikimedia Commons): vitamina D3 — domínio público; barra de apoio — CC BY-SA 2.0.

O que aumenta e o que protege

Fatores de risco

Intrínsecos: fraqueza, marcha/equilíbrio, baixa visão, confusão/delirium; hipotensão ortostática

Extrínsecos: fármacos (psicotrópicos), ambiente

alto
alto
moderado

Medidas de proteção

Exercício de equilíbrio e força (contínuo)

Revisar fármacos; corrigir visão e vit

Adaptar o ambiente; calçado e dispositivos

Alta
Moderado
Moderado

CASO CLÍNICO

Vamos pensar juntos

Sra. Conceição, 81 anos, hipertensa, em uso de clonazepam para dormir.
Caiu 2× em casa nos últimos 6 meses; agora tem medo de sair do quarto e

parou de caminhar. TUG = 18 s.

PAUSA ATIVA

Como você estratifica o risco e o que prioriza na prevenção?



Pergunta para fixar

Enuncie aqui a pergunta de múltipla escolha sobre o ponto-chave da aula.

A Solicitar
densitometri
e aguardar

C Prescrever
repouso para
evitar novas
quedas

B Avaliação
multifatorial +
exercício de

D Iniciar
antipsicótico
clonazepam
para o medo
de cair

TAKE-HOME MESSAGES

O que levar desta aula

- 01** Pergunte sobre quedas a TODO idoso, todo ano — é a porta de entrada da prevenção.
- 02** Queda não é 'da idade': fratura de quadril mata 20–30% em 1 ano e tira a independência.
- 03** O que mais funciona: exercício de equilíbrio (↓23%), revisar fármacos e vitamina D se déficit.

“Mais vale prevenir a queda do que tratar a fratura.”

PROVÉRBIO CLÍNICO

REFERÊNCIAS

Bibliografia — norma Vancouver

1. Montero-Odasso M, et al. World Guidelines for Falls Prevention and Management. Age Ageing. 2022;51(9):afac205.
2. Sherrington C, et al. Exercise for preventing falls in older people (Cochrane). Cochrane Database Syst Rev.
3. World Health Organization. Falls — key facts. Geneva: WHO; 2021. 2019;1:CD012424.
4. Bischoff-Ferrari HA, et al. Vitamin D and prevention of falls: meta-analysis. JAMA Intern Med.
5. Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Quedas em idosos — recomendações.
6. Seppala LJ, et al. STOPPFall: deprescribing fall-risk-increasing drugs, Age Ageing. 2021.
7. Ministério da Saúde (BR). Envelhecimento e saúde da pessoa idosa — quedas. Brasília: MS.
8. Guirguis-Blake JM, et al. Interventions to prevent falls (USPSTF evidence review). JAMA. 2018.



Obrigado.

Dr. Igor Cruz Moraes

igor.morais@rpt.org.br · WhatsApp (31) 9 9735-4136 ·
Instagram @igormorais1